Острый тонзиллит и фарингит

Клинические рекомендации от 31.10.2024 · взрослые и дети

Источник — клинические рекомендации Минздрава РФ, рубрикатор cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/306_3. Каждый пункт сверен с текстом КР 22.10.2026. Справочник не заменяет текст рекомендации.

Коды МКБ-10

нажмите код — скопируется

- **J02** Острый фарингит
- **J02.0** Стрептококковый фарингит
- **J02.8** Острый фарингит, вызванный другими уточнёнными возбудителями
- **J02.9** Острый фарингит неуточнённый
- **J03** Острый тонзиллит
- **J03.0** Стрептококковый тонзиллит
- **J03.8** Острый тонзиллит, вызванный другими уточнёнными возбудителями
- **J03.9** Острый тонзиллит неуточнённый

Главное

- Чаще всего тонзиллофарингит вызывают вирусы, и антибиотик при нём не нужен. Из бактерий лечения требует только БГСА — бета-гемолитический стрептококк группы А; стафилококк, пневмококк и другие микробы в мазке из зева означают колонизацию.
- По клинике вирусный тонзиллофарингит от бактериального не отличить. Пациентам старше 3 лет делают экспресс-тест на БГСА; если у ребёнка он отрицательный, результат подтверждают посевом.
- Антибиотик назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе. При вирусной инфекции он не помогает и не предотвращает присоединение бактерий.
- Препарат выбора — амоксициллин, курс 10 дней.
- Если через 48–72 часа приёма антибиотика улучшения нет, пересматривают диагноз: это может быть ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.
- Рутинно не нужны СРБ, прокальцитонин, общий анализ крови в поликлинике, АСЛ-О и контрольный мазок после лечения.

Клиника и классификация

раздел 1 текста КР

Определение

Острый тонзиллофарингит — острое инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфоидной ткани ротоглотки: нёбных миндалин и фолликулов задней стенки глотки. Термин объединяет острый тонзиллит и острый фарингит, потому что чаще воспалены оба отдела.

По локализации различают тонзиллит, фарингит и тонзиллофарингит — по тому, какой отдел ротоглотки воспалён больше. По причине — стрептококковый и нестрептококковый (вирусный). Тактику определяет именно причина.

Клиническая картина

Болезнь начинается остро, обычно с температурой выше 38 °C (реже она нормальная или субфебрильная) и боли в горле, которая усиливается при глотании и может отдавать в ухо. Регионарные лимфоузлы бывают увеличены и болезненны, маленькие дети отказываются от еды. Состояние удовлетворительное или средней тяжести.

На стрептококк указывают увеличенные подчелюстные или переднешейные лимфоузлы, высокая температура, сильная боль в горле, «пылающий зев», налёт на миндалинах и отсутствие насморка, кашля и конъюнктивита.

На вирусную природу указывают насморк, конъюнктивит и кашель. При инфекции вирусом Эпштейна — Барр бывают генерализованное увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки. Петехии на мягком нёбе встречаются и при стрептококке, и при вирусе Эпштейна — Барр.

При тонзиллофарингите миндалины увеличены симметрично, и этим он отличается от паратонзиллярного абсцесса.

Что важно для выбора тактики

Все штаммы БГСА чувствительны к пенициллину и всем бета-лактамам. К макролидам устойчив примерно каждый пятый штамм, к клиндамицину — 3–4%.

Если при клинике тонзиллофарингита из зева высевают *S. aureus*, *S. pneumoniae* или другие бактерии, это колонизация, и антибиотики не нужны.

Дифференциальная диагностика

Инфекционным мононуклеозом чаще болеют подростки и молодые взрослые до 30 лет. Характерны слабость, увеличение лимфоузлов, печени и селезёнки, атипичные мононуклеары в крови. Диагноз подтверждают ПЦР на ДНК вируса Эпштейна — Барр и IgM к капсидному антигену.

Синдромом «рука — нога — рот» болеют дети до 5 лет, обычно летом: во рту появляются пузырьки без налётов на миндалинах, а на кистях и стопах — сыпь.

При ангине Симановского — Плаута — Венсана на одной миндалине образуется некротическая язва с гнилостным запахом.

При дифтерии зева налёт плотный, снимается с трудом и оставляет кровоточащую поверхность.

Синдром Маршалла (PFAPA) — периодическая лихорадка до 39–40 °C с тонзиллитом или фарингитом, афтозным стоматитом и шейным лимфаденитом. Приступы повторяются каждые 1–2 месяца, средний возраст детей — 5 лет, приступ быстро снимают системные кортикостероиды.

Диагностика

раздел 2 текста КР
Диагноз ставят по жалобам на сильную боль в горле при глотании, по осмотру (гиперемия, инфильтрация и отёк миндалин, увеличенные регионарные лимфоузлы) и по результату экспресс-теста на БГСА или посева.

Каждого пациента должен осмотреть оториноларинголог, педиатр, врач общей практики или терапевт.

У каждого пациента нужно отличить стрептококковый тонзиллофарингит от вирусного.

Экспресс-тест на БГСА делают пациентам старше 3 лет. Если он положительный, посев не нужен. Если отрицательный, взрослому посев тоже не нужен, а у ребёнка и подростка результат подтверждают посевом.

Детям до 3 лет тест обычно не делают; исключение — когда стрептококковый тонзиллит есть у кого-то рядом, например у старшего брата или сестры.

Мазок из зева на стрептококк группы А сеют пациентам старше 3 лет, если экспресс-тест не делали или он отрицательный. Результат готов в течение 72 часов.

Мазок берут до начала антибиотиков, до утренней гигиены рта, натощак или через 2 часа после еды, под контролем орофарингоскопии, не касаясь зубов и языка, из устьев крипт миндалин и с задней стенки глотки.

Что не нужно рутинно

В поликлинике СРБ и прокальцитонин не помогают отличить вирусное воспаление от бактериального. СРБ определяют при госпитализации, прокальцитонин — у тяжёлых пациентов в стационаре.

Общий анализ крови в поликлинике делают только при необходимости, например чтобы исключить мононуклеоз.

АСЛ-О годится только для ретроспективной диагностики, потому что повышается лишь на 7–9-й день. Его определяют при подозрении на ревматическую лихорадку, гломерулонефрит или PANDAS.

Контрольный мазок на БГСА после лечения не нужен, если пациент не относится к группе высокого риска ревматической лихорадки и симптомы не повторяются.

У детей старше 3 лет обращают внимание на насморк, кашель, охриплость и конъюнктивит: при стрептококковой инфекции они бывают не больше чем у 10% и только при сопутствующей вирусной инфекции.

Шкала Центора — МакАйзека

Признак	Баллы
Температура тела выше 38 °C	1
Отёчность и гиперемия миндалин, налёты на задней стенке глотки и миндалинах	1
Нет катаральных явлений и кашля	1
Переднешейный и/или подчелюстной лимфаденит	1
Возраст 5–14 лет / 15–44 года / 45 лет и старше	1 / 0 / −1

Баллы	Вероятность БГСА: ≥15 лет / 3–14 лет	Тактика
0–1	7–12% / 8–14%	Нет показаний к посеву и/или антибиотикам
2–3	21–38% / 23–37%	Антибиотик — по экспресс-тесту и/или посеву
4 и более	57% / 55%	Антибиотик по клинической картине

Шкала FeverPAIN

Один балл дают за каждый признак: температура за последние сутки, налёт на миндалинах, обращение в первые 3 дня из-за сильных симптомов, выраженные гиперемия и отёк миндалин, отсутствие кашля и насморка.

При 0–2 баллах вероятность стрептококка групп A, C или G — 16%, при 3 баллах — 43%, при 4–5 баллах — 63%.

Шкалы помогают найти пациентов с высокой вероятностью стрептококковой инфекции, но диагноз с абсолютной точностью не ставят.

Лечение

раздел 3 текста КР

Антибиотики

При вирусной инфекции системные антибиотики не назначают: они не действуют и не предотвращают присоединение бактерий.

Назначать антибиотики при вирусном тонзиллофарингите «для профилактики» не рекомендуется.

Антибиотики назначают только при доказанной или очень вероятной стрептококковой природе.

При стрептококковом тонзиллите препарат выбора — амоксициллин.

При мононуклеозе может появиться сыпь на амоксициллин, но она бывает и от других антибиотиков, и без них, поэтому при мононуклеозе любых системных антибиотиков лучше избегать.

Пенициллины, цефалоспорины, линкозамиды и макролиды, кроме азитромицина, назначают на 10 дней.

При рецидивирующем стрептококковом тонзиллофарингите назначают амоксициллин с клавулановой кислотой или клиндамицин (детям старше 3 лет) на 10 дней. Пациента консультирует оториноларинголог, чтобы исключить хронический тонзиллит, а у детей — синдром PFAPA.

Если через 48–72 часа приёма антибиотика температура и боль не уменьшились, пересматривают диагноз: вероятнее всего, это ОРВИ или инфекционный мононуклеоз.

При нетяжёлой аллергии на пенициллины назначают цефалоспорины II–III поколения: цефуроксим, цефиксим, цефдиторен или цефподоксим. Перекрёстная аллергия с пенициллинами бывает меньше чем в 2% случаев для II поколения и меньше чем в 1% для III.

Уровни доказательности у этих препаратов в КР разные: у цефуроксима — УУР С, УДД 5; у цефиксима — С и 5 для детей, В и 1 для взрослых; у цефдиторена — С и 2; у цефподоксима — В и 2. Курс — 10 дней.

При аллергии на цефалоспорины или тяжёлой реакции на бета-лактамы (анафилактический шок, отёк гортани, тяжёлая крапивница) назначают макролиды или линкозамиды, помня об устойчивости стрептококка к макролидам.

Бензатина бензилпенициллин вводят однократно внутримышечно вместо курса таблеток, только если есть сомнения, что пациент будет их принимать. Детям с массой до 27 кг — 600 тысяч ЕД, больше 27 кг — 1,2 миллиона ЕД.

Дозы внутрь

Препарат	Взрослые	Дети
Стартовая терапия — 10 дней		
Амоксициллин[1]	1,5 г/сут в 3 приёма или 1,0 г/сут в 2 приёма	50 мг/кг/сут в 2–3 приёма
Альтернатива		
Бензатина бензилпенициллин[2] **в/м, однократно**	2,4 млн ЕД	менее 27 кг — 600 тыс. ЕД; более 27 кг — 1,2 млн ЕД
Цефалексин	старше 10 лет: 500–1000 мг/сут в 2 приёма	3–10 лет, только таблетки: 25–50 мг/кг/сут в 4 приёма, не более 1000 мг/сут
Рецидив и/или неэффективность амоксициллина		
Амоксициллин + клавулановая кислота[1] [3] **(во время еды)**	1750 мг/сут по амоксициллину в 2 приёма	50 мг/кг/сут по амоксициллину в 2–3 приёма

Препарат	Взрослые	Дети
Нетяжёлая аллергия на пенициллины		
Цефуроксим (сразу после еды)	1,0 г/сут в 2 приёма	20 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефиксим	400 мг/сут в 1–2 приёма	8 мг/кг/сут в 1–2 приёма
Цефдиторен (после еды)	400 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 400 мг/сут в 2 приёма
Цефподоксим (во время еды)	200 мг/сут в 2 приёма	с 12 лет: 200 мг/сут в 2 приёма
Аллергия на цефалоспорины и/или тяжёлая реакция на пенициллины		
Кларитромицин	500–1000 мг/сут в 2 приёма	15 мг/кг/сут в 2 приёма
Джозамицин (между едой)	1,0 г/сут в 2 приёма	40–50 мг/кг/сут в 2 приёма
Азитромицин (за 1 час до еды)	500 мг/сут в 1 приём, **3 дня**	20 мг/кг/сут в 1 приём, 3 дня
Мидекамицин (за 1 час до еды)	1,2 г/сут в 3 приёма	старше 3 лет: 50 мг/кг/сут в 2 приёма
Спирамицин	6 млн МЕ/сут в 2 приёма	старше 6 лет, более 20 кг: 300 тыс. МЕ/кг/сут в 2 приёма
Клиндамицин (запивать большим объёмом воды)	0,6 г/сут в 4 приёма	20 мг/кг/сут в 3 приёма

[1] С осторожностью при подозрении на инфекционный мононуклеоз. [2] Если пациент может не соблюдать назначения, при ревматической лихорадке у него или у родственников, при неблагоприятных бытовых условиях и вспышках в коллективе. [3] Клавулановой кислоты — не больше 10 мг/кг в сутки из-за риска диареи.

> Текст КР и таблица 1 расходятся. Цефуроксим взрослым: в тексте — 250 мг 2 раза в сутки, в таблице — 1,0 г в сутки. Амоксициллин с клавулановой кислотой детям: в тексте — 40 мг/кг в сутки, в таблице — 50 мг/кг. Амоксициллин детям: в тексте — 50 мг/кг в сутки в 2 приёма, не больше 1000 мг в сутки, в таблице — в 2–3 приёма без ограничения. Клиндамицин: в тексте взрослым 300 мг 2 раза в сутки, детям 3–12 лет 20–30 мг/кг в сутки, в таблице — 0,6 г в сутки в 4 приёма и 20 мг/кг. Выбор за врачом; проверьте дозы по инструкции в ГРЛС.

Парентерально

Если пациент не может или не хочет принимать препарат внутрь, его вводят парентерально до стабилизации, а затем переходят на приём внутрь.

Препарат	Дети	Взрослые
Ампициллин	до 1 года 100 мг/кг/сут; 1–4 года 100–150 мг/кг/сут; от 4 лет 1–2 г/сут; в 4 введения	и дети более 40 кг: 250–500 мг каждые 6 ч
Амоксициллин + клавулановая кислота в/в	90 мг/кг/сут в 3 введения	и дети старше 12 лет: 1,2 г каждые 8 ч
Ампициллин + сульбактам	до 12 лет или менее 40 кг: 150 мг/кг/сут в 3–4 введения	1,5–3 г каждые 6–8 ч
Цефазолин	1 мес — 18 лет: 25–50 мг/кг/сут (тяжёлые — 100) в 3–4 введения	2,0 г каждые 8 ч

Препарат	Дети	Взрослые
Цефтриаксон	до 12 лет: 20–80 мг/кг/сут 1 раз (более 50 кг — до 2 г/сут)	и дети старше 12 лет: 2 г 1 раз в сутки
Цефотаксим	до 12 лет: 100–150 мг/кг/сут в 2–4 введения	и дети старше 12 лет или более 50 кг: 1–2 г каждые 6–8 ч
Клиндамицин (непереносимость β-лактамов)	20–40 мг/кг/сут в 3–4 введения	0,4–0,6 г каждые 6–8 ч

Симптоматическое лечение

При температуре и боли назначают ибупрофен, парацетамол или, старше 15 лет, ацетилсалициловую кислоту; детям — только парацетамол и ибупрофен. Здоровым детям старше 3 месяцев жаропонижающее дают при температуре выше 39,0 °C в прямой кишке или выше 38,5 °C в подмышке.

Ибупрофен взрослым — 200–400 мг, детям — 7,5 мг/кг, не больше 30 мг/кг в сутки. Парацетамол взрослым — 500–1000 мг, детям — 10–15 мг/кг каждые 6 часов, не больше 60 мг/кг в сутки.

Системные кортикостероиды при боли в горле рутинно не назначают.

Исключение — сильный дискомфорт и угроза асфиксии, например при мононуклеозе. Тогда однократно внутрь дают #дексаметазон 0,3 или 0,6 мг/кг или #преднизолон 1 мг/кг (УУР В, УДД 1).

При сильной боли назначают местные анестетики и НПВП в спреях, растворах и таблетках для рассасывания с учётом возраста. При стрептококковой инфекции местное лечение антибиотики не заменяет.

Бензидамин разрешён с 3 лет, бензокаин с хлоргексидином — старше 4 лет, флурбипрофен — старше 12 лет, кетопрофен — с 12 лет. Средства для горла вообще применяют с 3–4 лет из-за риска ларингоспазма. Миндалины не «смазывают» и налёт механически не снимают.

Дополнительно, в том числе курсами между рецидивами, можно применять растительные препараты: корень алтея, ромашку, тысячелистник, кору дуба, хвощ, листья грецкого ореха, одуванчик.

Пища должна быть щадящей и мягкой: не острой, не кислой, не солёной, не горячей и не холодной.

При неосложнённом тонзиллофарингите хирургическое лечение не рекомендуется.

Профилактика, госпитализация, осложнения

разделы 5–7 текста КР
После тесного бытового контакта со стрептококковой инфекцией антибиотики для профилактики назначают беременным со сроком 37 недель и больше, новорождённым и родильницам в первые 28 дней, а также людям 75 лет и старше.

Больных стрептококковым тонзиллофарингитом изолируют от организованных коллективов и ограничивают их контакты.

При рецидивирующем тонзиллофарингите для профилактики рецидивов назначают лизаты бактерий.

При рецидивирующем тонзиллофарингите применяют БАД с естественными бактериями ротоглотки, например *S. salivarius* K12.

После стрептококкового тонзиллофарингита пациента наблюдают месяц: общий анализ крови и мочи делают через 7–10 дней и через 3 недели, а при жалобах со стороны сердца — ЭКГ.

Лечат обычно амбулаторно. На антибиотиках улучшение наступает через 12–24 часа. В детский коллектив ребёнок возвращается после полного выздоровления.

В инфекционное отделение госпитализируют при тяжёлом состоянии и если из-за отказа от еды и питья нужна инфузионная терапия. При подозрении на гнойное осложнение, атипичной картине или необходимости операции пациента консультирует оториноларинголог и его госпитализируют в хирургическое отделение.

Стрептококковая инфекция даёт гнойные осложнения — паратонзиллярный, парафарингеальный, ретрофарингеальный абсцессы, гнойный лимфаденит — и негнойные: острую ревматическую лихорадку, ревматическую болезнь сердца, постстрептококковый гломерулонефрит, стрептококковый токсический шок, PANDAS.

Источник и актуальность

всегда полностью

Документ	Клинические рекомендации «Острый тонзиллит и фарингит (Острый тонзиллофарингит)»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 31.10.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР — не реже одного раза в три года: следующая ожидается не позднее октября 2027
Код в рубрикаторе	`306_3` · открыть текст КР ↗
Разработчики	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Пациенты	Взрослые и дети

Неточности в самом тексте КР

- Дозы цефуроксима, амоксициллина, амоксициллина/клавуланата и клиндамицина в тексте и в таблице 1 различаются — подробно в блоке «Текст КР и таблица 1 расходятся» на вкладке «Лечение».
- В таблице 1 у бензатина бензилпенициллина в колонке «Дети» написано «у пациентов старше 12 лет при m<27 кг 600 тыс. ед» — по смыслу это дозировка по массе тела, как в тексте КР.
- Таблицы доз в PDF извлекаются вперемешку: все строки сверены по изображениям страниц 19–21.